

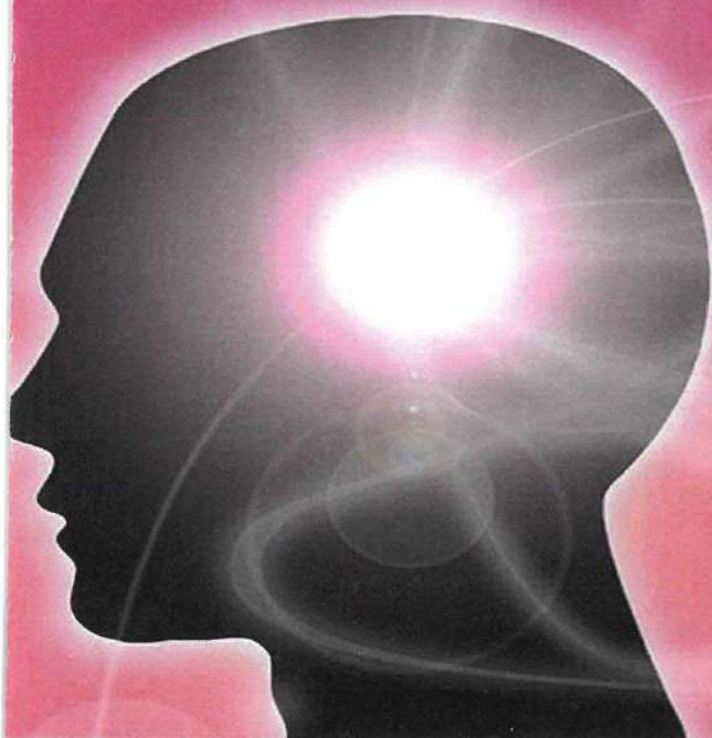
FORMACIÓN EN DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES

Dictado por

CHRISTIAN FLÈCHE

Escuela Francesa de Decodificación
Biológica Original

FORMACIÓN EN BASES: MÓDULO III





Descodificación
Biológica
Original

Bio-bases

Módulo 3



Christian FLECHE

*Enregistré sous le numéro 93.83.04623.83.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat*

101, allée Picasso - 83470 Saint Maximin

Tel : 06 13 12 00 79

Email : fleche.dbo@gmail.com

Site : <http://www.biodecodage.com/>



« Association Internationale de Psycho-Bio-Thérapie » :

Email : asso.psychobiotherapeute@gmail.com

Site : <http://psychobiotherapeute.org/fr/>

asso.psychobiotherapeute.org

ÍNDICE

<u>2ª ETAPA DE LA BIOLOGÍA : EL CEREBELO</u>	<u>3</u>
<u>ESQUEMA DEL CEREBELO</u>	
<u>LOS TRES NIVELES DEL CONFLICTO</u>	<u>5</u>
<u>LA CRISIS ÉPICA</u>	<u>7</u>
<u>LOS MEDICAMENTOS</u>	<u>9</u>
<u>EL CEREBRO, LAS NEURONAS</u>	<u>11</u>
<u>LOS DOLORS DE CABEZA, MIGRAÑAS Y CEFALÉAS</u>	<u>14</u>
<u>LOS TUMORES CEREBRALES</u>	<u>16</u>
<u>LAS ENFERMEDADES CANCEROSAS</u>	<u>17</u>
<u>LA GOMA Y EL TINTERO</u>	<u>23</u>

ANEXO:

ARTÍCULO:

-EL CÁNCER: UN PROGRAMA DE SUPERVIVENCIA

2ª ETAPA DE LA BIOLOGÍA: EL CEREBELO

Hoja embrionaria



Mesodermo ANTIGUO

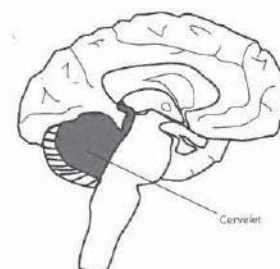
Se formó en la época del pasaje del medio líquido al terrestre de los organismos vivos, debido a la necesidad vital y a la **obligación de protegerse del entorno**. Al salir de la etapa de lo estrictamente necesario para sobrevivir, pasamos a una nueva noción de nuestro interior prestando una atención específica en “protegernos de los ataques”.

Relé cerebral



El CEREBELO CEREBRAL

El cerebelo es la parte del encéfalo, parecida a una coliflor, situada inmediatamente por debajo del cerebro y detrás del tronco cerebral (en el extremo superior de la médula espinal)



Tejidos



MEMBRANAS DE PROTECCIÓN

Estos tejidos tienen una **función de PROTECCIÓN en un contexto vital**.

➔ Pericardio, Pleura, Peritoneo, Dermis, Glándulas Mamarias, Meninges.

Conflictos



Conflicto que atenta a la integridad
Conflicto de agresión, de sentirse agredido
Conflicto de mancillamiento

Tejidos	Conflictos
Pericardio	Agresión a la integridad o ataque «a mi corazón»
Pleura	Agresión a la integridad o ataque al interior de la caja torácica
Peritoneo	Agresión a la integridad o ataque del contenido de la cavidad abdominal (a menudo vivido en situación de hiper estrés real o imaginario)
Glándula mamaria	Agresión a la integridad del nido : - A la izquierda : noción estricta de nido (madre/hijos) - A la derecha : noción más amplia de nido (pareja, hermanos, colegas...) (a la inversa para los zurdos)
Dermis	Agresión a la integridad Desgarro, con una connotación de mancillamiento y por extensión un resentir de estar mutilado, deforme...
Meninges	Agresión a la integridad del encéfalo, de la cabeza
Gran epiplón	Agresión a la integridad en relación a un asunto sucio, indigesto, asqueroso
Labios mayores	Agresión a mi integridad sexual
Escroto, bolsas	Agresión a la integridad de mis testículos

LOS TRES NIVELES DE CONFLICTOS

La biología no sabe ni puede hacer la diferencia entre las formas de información que le llegan. No hace diferencia alguna entre la información que le llega del interior del cuerpo, de su propia biología, y una información que proviene del pensamiento o del exterior. El ser humano resiente de manera idéntica los acontecimientos en sentido propio como en sentido figurado, ya que traspasa todas sus vivencias, mediante su resentir o vivencia interior, a la biología.

RESENTIRES REALES

- Podemos comer una ostra en mal estado y la reacción biológica del estómago será vomitar.
- Podemos sufrir una agresión real en el músculo cardíaco y desencadenar una patología del pericardio.
- Podemos tener un golpe de sol que provocará una quemadura en la piel: aquí estamos en el plano real.

Ejemplos :

- Un hombre recibe un hachazo que abre su tórax y le arranca tejido muscular de su pecho izquierdo, tiene miedo por su corazón → patología del pericardio (engrosamiento de la membrana pericárdica).

- Una joven pasea por la calle bajo las ventanas de un colegio y unos chicos le tiran un petardo que cae en su escote; el petardo explota en su piel a la altura del corazón → ella tiene miedo, realmente miedo por su corazón.

- La señora X gana muy poco dinero y pasa mucha hambre; sufre un bioshock al pasar por delante de una tienda de comestibles en la que solo puede comprar pasta desde hace meses: ve tomates, pero no se los puede permitir → se muere literalmente de hambre.

- La señora Y se muda a un apartamento con calefacción de gas ciudad y tiene miedo a morir asfixiada por falta de aire → desarrolla un tumor de los alvéolos pulmonares que tienen como función multiplicar la superficie de intercambio para atrapar más oxígeno.

***En este nivel de conflicto real, la solución debe ser real:
Encontrar algo que comer, proteger su corazón, etc.***

RESENTIRES VIRTUALES (IRRACIONALES)

TRANSPOSICIÓN DEL IMAGINARIO

Este es el plano de experiencia más frecuente.

La solución biológica, la enfermedad, no soluciona forzosamente el problema.

- Si alguien vive mal un acontecimiento, de una manera indigesta, su cerebro desencadenará igualmente y como solución, un vómito, una secreción de ácido, un pólipo o un cáncer...

Ejemplos :

- Una persona sufre hipertensión arterial y padece por su sistema cardiovascular, va a codificar el pericardio de manera inútil ya que los vasos arteriales no están en el interior del corazón, del pericardio. La solución puede al mismo tiempo generar otros problemas, ya que el engrosamiento puede provocar una insuficiencia cardíaca.

- Otra persona tiene miedo a que le falte el dinero. Su biología le despierta el temor de la falta de alimentos; es un resentir de « carencia » que puede provocar una patología de hígado.

- « Tengo un resentir de mancillamiento, porque alguien ha hablado mal de mí o me ha insultado ». Como consecuencia, se genera un cáncer de piel. Estamos ante una transposición biológica. En cierto modo, esto no sirve para nada psicológicamente hablando.

- Un cirujano riquísimo, en un viaje organizado a la India, se encuentra con una mujer mendigando en la calle, medio muerta de hambre. Él se pone en su lugar, se identifica con ella, resiente « el no tener nada » y desarrolla un nódulo en el hígado cuya función es almacenar glucógeno. Es un conflicto por identificación que, según la lógica biológica sería: « Si yo no puedo actuar en el cuerpo del otro, actúo en el mío ». Este nódulo es totalmente inútil tanto para la mujer como para este hombre; es el programa de referencia biológica que se ha puesto en marcha.

RESENTIRES, SEMÁNTICA Y SIMBÓLICA

- Nos encontramos en este plano de experiencia en el simbolismo, la semántica y el juego de palabras.

Ejemplos :

- La Señora X se divorcia de su marido pero sigue compartiendo el mismo techo: cada uno en su habitación, una línea separa la cocina en dos partes, cada uno tiene su paquete de biscotes y su pareja sexual. La casa se halla como partida en dos → La Señora X tiene diabetes. En griego, Dia = división, separado, cortado en dos, y en hebreo, Beth = casa.

DIABETE(S) → DIA - BETE = DIA - medio y BETH - casa → casa partida en dos. Esto es semántica.

- El corazón es para la biología un símbolo de territorio a conquistar y conservar; Cuando alguien siente que su territorio es amenazado o atacado, quiere protegerlo y codifica el pericardio, el envoltorio protector del corazón, que simboliza el territorio. Así pues, el deseo de proteger su territorio de las agresiones, puede codificarse en el pericardio: una mujer teme por su jardín marchito, todas las plantas mueren → su territorio muere. Ella lo quiere proteger de las agresiones; en descodificación, el territorio es el corazón. **Esto es simbólico.**

LA CRISIS ÉPICA O C.E.

DEFINICIÓN

Se llama también crisis epileptoide; a veces se manifiesta con una crisis de epilepsia. Separa las dos fases A y B de vagotonía.

- En vagotonía, cuando aparece la C.E., el cuerpo se coloca en estrés, en simpaticotonía: debe eliminar el agua que acompaña toda reparación para encontrar el confort y salir del peligro del edema cerebral.

Por ejemplo, después de la resolución de un conflicto motor muy breve (*hay impedimento para moverse cuando uno quiere, o bien, debe moverse cuando no lo quiere*) asociado a un conflicto de miedo, una vez en vagotonía, se crea un edema cerebral y como el edema contiene agua y el cerebro tiene un funcionamiento eléctrico (¡peligro!). El edema se vuelve peligroso ya que puede comprimir el cerebro, por ello se inicia la búsqueda de una solución biológica para que el cerebro pueda eliminar este líquido **drásticamente**: La persona viene de curar un conflicto y el cerebro necesita eliminar agua. ¿Cómo eliminar este líquido? ¿Cómo va a actuar la biología? El cerebro pone nuevamente al cuerpo en estrés, en simpaticotonía, y el cuerpo elimina el agua. El estrés durará cierto tiempo y las C.E. aparecerán tantas veces como sean necesarias para salir del peligro, es decir, hasta que el edema cerebral haya sido eliminado.

SENTIDO BIOLÓGICO

El sentido biológico de la C.E. es el de desconectar al cerebro de un estrés biológico peligroso. El cuerpo está en peligro → se coloca en estrés.

FASES A Y B DE LA VAGOTONÍA

La C.E. va a separar la etapa de curación o vagotonía, en dos momentos: fase A y fase B.

- *Fase A exudativa* : lo urgente es curar el cerebro.
- *Fase B cicatricial*: el cerebro se repara, el agua se elimina: fase de cicatrización y vuelta a la normalidad.

Durante la C.E., se siente mucho frío aunque anteriormente tuviéramos calor; esto dura un poco, luego la fiebre reaparece.

Es el momento de la verdad, la crisis épica y lo que se cuestiona es: *¿Es esta solución una buena solución?*

- *Si es que sí*: transición a la fase B de vagotonía, el cuerpo finaliza su reparación, vuelve a la normalidad y todo está bien.
- *Si es que no*: permanecemos en la fase A, con múltiples crisis épicas, pasando a la **cronicidad...**

- **La cortisona y la vagotonía:** la cortisona **prescrita por un médico** y tomada en fase B no supone problema alguno = debilitará y alargará la curación pero habrá una vuelta a la normalidad; la cortisona en fase A es más problemática.

¿CUÁNDO SOBREVIENTE LA C.E.?

1. La mayoría de las veces, **la C.E. sobreviene en vagotonía.**
 2. Cuando **la simpaticotonía nos coloca en peligro** (demasiado estrés), se producirá este tipo de crisis para facilitar el pasaje biológico obligatorio a vagotonía (es el sentido biológico del orgasmo, que saca al animal del peligro de estar demasiado ocupado con el apareamiento).
- La C.E. por lo tanto, puede sobrevenir también en un conflicto activo motor, aunque lo más frecuente es que se produzca en medio de la fase de vagotonía. En tal caso, la C.E. sobreviene más bien por la noche.
 - Esta C.E. existe en todas las enfermedades y en función de la zona del cerebro, los síntomas serán distintos y más o menos “escandalosos”.

EJEMPLOS DE CRISIS ÉPICAS

- ❑ **Crisis de epilepsia** o gran mal: conflicto motor + miedo.
- ❑ **Crisis de ausencia** o pequeño mal (*estar en la luna*): conflicto de separación + miedo.
- ❑ **Infarto:** conflicto de pérdida de territorio. En la crisis épica, el edema se forma en el cerebro, en el foco de mando de las arterias coronarias.
Infarto = problema cerebral en el foco de mando de las arterias coronarias que constituyen el tejido que corresponde al resentir de “pérdida de territorio”.

LOS MEDICAMENTOS

Interés :

La toma de medicamentos tendrá incidencia sobre los conflictos de los pacientes y su "reparación".

Los efectos de los medicamentos serán diferentes en función de:

- Las fases de la enfermedad - De simpaticotonía, de estrés
- De vagotonía, de reparación

Los 2 grandes grupos de medicamentos :

- Los simpaticotónicos
- Los vagotónicos

Los simpaticotónicos :

Adrenalina, noradrenalina, cortisona, cafeína, teína, penicilina, antibióticos, antihistamínicos, la mayoría de antimigrañas, quimioterapia y radioterapia.

Uno de los simpaticotónicos más importante es la cortisona → + despierto + energía

- Si la toma de cortisona se realiza durante la 1ª fase de vagotonía (Antes de la crisis épica)

→ La cortisona anti-inflamatoria → ↓ edema

→ Los síntomas desaparecen → la vagotonía se detendrá ↓

Al suspender la toma de cortisona :

→ Los síntomas regresan + la cortisona ha reabsorbido el edema, eliminándolo de los tejidos (estrés biológico)

→ Estrés en curso + estrés biológico → nuevo tratamiento

→ Vagotonía incompleta o imposible

La dosificación de la cortisona será primordial. Si la dosis es débil, la fase de enfermedad será más larga pero posible.



- Si la toma de cortisona se realiza durante la 2ª fase de vagotonía (Después de la crisis épica)

→ No hay problema. Los síntomas de vagotonía desaparecen y no regresan

- Si la toma de cortisona se hace en fase de simpaticotonía → conflictos múltiples

La cortisona puede ser prescrita por un médico a la vista de los síntomas (de vagotonía) de un 1^{er} conflicto. Sin embargo, ¿qué ocurre si la persona tiene otros conflictos que sin ser el drama de su vida, si provocan un pequeño estrés? Este conflicto puede ser silencioso y ligeramente activo.

Para este 2° conflicto, la toma de cortisona coincidirá con la fase de simpaticotonía

- La cortisona va a despertar y ↗ la intensidad de este conflicto → el conflicto se vuelve activo
- Esto provocará la aparición de los efectos secundarios de los medicamentos !

Los vagotónicos:

Anestésicos, opiáceos, tranquilizantes, somníferos, sedantes, anticonvulsivos, alcohol...

- **Si se toma en fase de vagotonía → doble vagotonía**
Ej. : anestesia → despertar largo y difícil
Ej. : alcohol → vómitos, dolor de cabeza
- **Si es en fase de estrés → medicamentos menos eficaces**
Necesidad de más producto, de una dosificación más fuerte para ser eficaz.
Ej. : anestesia → más producto y despertar más rápido
Ej. : alcohol → violencia (mal beber)

Abordaje terapéutico

Si aparecen síntomas tras un tratamiento médico (efectos secundarios)!

→ Hay que trabajar sobre el o los conflictos y no sobre el tratamiento!

1. Preguntar al paciente sobre los conflictos ligeramente activos antes del tratamiento
2. Verificar como vive el paciente este tratamiento

Ejemplos :

- *Un paciente tiene una úlcera de estómago desde que toma cortisona:*
Tiene un pequeño conflicto de contrariedad en el territorio que se "despierta" desde la toma de cortisona.
- *Un paciente tiene un pequeño bioshock de separación (partida de su hermano) pero no tiene ningún síntoma; sin embargo tiene reumatismos → prescripción de cortisona → el paciente pasa a doble simpaticotonía → el conflicto que era manejable se vuelve insostenible → Como si: " desde que tomo la cortisona añoro más a mi hermano" → eccema*
- *Conflicto de « pequeña guarrada » → si toma de cortisona → diarrea*
- *Radioterapia: una mujer tiene cáncer de mama → la radioterapia quema localmente*
Es una simpaticotonía local (estrés local) → un shock biológico real!
Tras este shock biológico, el cuerpo va a reparar → pasa a vagotonía
Si la paciente ya está en vagotonía, ésta aumenta y hay más fatiga y la recuperación es más larga.

EL CEREBRO

EL CEREBRO ES UN INTERFAZ

- Interfaz entre lo material (concreto: observamos cosas materiales, concretas, que se convertirán en emociones, en pensamientos) y lo inmaterial (tenemos proyectos, deseos o sueños que el cerebro concretizará). Pasamos de lo material a lo inmaterial y vice versa.
- Interfaz entre vida interior, vida psíquica, vida emocional, vida orgánica, vida celular.
- El cerebro y el cuerpo son uno, y las funciones biológicas evolucionan con ellos, juntos.

PROPORCIONES

- El cerebro pesa 1,3 kg para un volumen de 1.500 cm³.
- Está constituido por miles de millones de neuronas. Es la calidad de las neuronas, de las conexiones, lo que cuenta, más que la cantidad. *10% neuronas, 90% glías*
- Representa un 2% del peso corporal y consume un 20% de la energía.

UNA INFINIDAD DE CONEXIONES

- Las conexiones son infinitas. Cada neurona está ligada a millares de neuronas, siendo las combinaciones infinitas.
- Permanentemente, las conexiones neuronales se hacen y deshacen ya que diariamente se destruyen millares de neuronas.
- En fase de estrés, muchas conexiones se deshacen y millares de neuronas suplementarias son destruidas.
- También en la última fase de curación, varios millares de neuronas son destruidas ya que el inconsciente tiene la certeza de que el conflicto no volverá a repetirse, es cuando la función biológica puesta en marcha carece ya de sentido.

CEREBRO Y TERAPIA

- Un conflicto = un conflicto crea una red de conexiones, lo que constituye un anclaje.
- En terapia = se crean **nuevas conexiones** a través de nuevas experiencias. Por lo tanto, han de hacerse nuevas conexiones para realizar nuevas elecciones. Creando nuevas conexiones, las otras partes del cortex podrán retomar en parte, la función de antiguas conexiones.
- No se borra lo ocurrido en el pasado, lo que ha existido hasta ahora, pero se da la posibilidad de **elección**.

PLÁSTICO Y RÍGIDO A LA VEZ

- El cerebro tiene una intensa actividad interna que proyecta su mirada hacia el exterior.
- Oímos lo que hemos aprendido a oír, vemos lo que hemos aprendido a ver y es lo mismo para la comprensión, las creencias, etc. pero al mismo tiempo, el cerebro es móvil.
- El cerebro es a la vez plástico, flexible ya que aprende, y también es rígido pues graba y tiene una memoria.

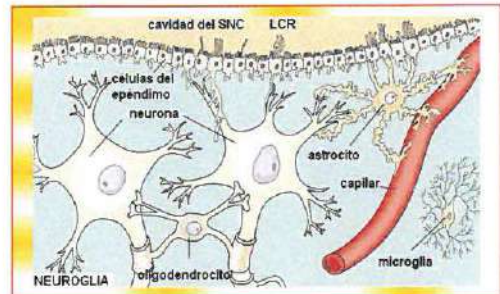
LENGUAJE SIMBÓLICO Y LENGUAJE REAL

El cerebro solo conoce el lenguaje simbólico y no la realidad.

LAS NEURONAS

CÉLULAS GLIALES

- Microglías, móviles (mesodermo).
- Macroglías, proliferan en lugar fijo (ectodermo):
 - Los astrocitos ayudan a la cicatrización del cerebro.
 - Los oligodendrocitos aíslan la neurona.



- Las neuronas tienen **formas diversas** según su localización.
 - Las *células gliales* están alrededor de las neuronas protegiéndolas, alimentándolas, las sostienen, están a su servicio.
 - Las neuronas no hacen más que pensar y las células gliales actúan para ellas.
- Tenemos un 90% de células gliales por un 10% de neuronas, en consecuencia son 9 células gliales para 1 neurona!

Patologías: La mayoría de las patologías del cerebro son patologías de las células gliales y no de las neuronas (no conocemos tumores de neuronas, ni cáncer de neuronas; no saben multiplicarse o dividirse, sólo saben morir) son las células gliales que se multiplican.

Ellas reparan el cerebro multiplicándose (es el edema) y aislando la parte afectada del resto del cerebro durante la etapa de curación. Tienen un gran poder de división.

- Las células *gliales son una interface entre neuronas y vasos sanguíneos*. La sangre pasa a través de las células gliales que toman todo lo que necesitan y lo transmiten al cerebro, a las neuronas. Las células gliales aseguran también, junto con las meninges y el cráneo, la protección del cerebro: la sangre no está en contacto con el cerebro sino con la glía que sirve de intermediario.
- A veces las células gliales **tendrán que efectuar algo más que sus tareas básicas** (ver capítulo « tumor cerebral »)

TRÍADA PSIQUE - CEREBRO - CUERPO

Psique + cerebro + cuerpo → psico-cerebro-orgánico.

Un mismo conflicto, la desvalorización por ejemplo, va a dar posiblemente tres patologías:

- Psiquismo → depresión, malestar, megalomanía, « aires de grandeza »,
- Cerebro → patología del control cerebral de los huesos, del músculo, etc. (según su historia).
- Cuerpo → huesos, músculos.

En función de la persona, tendrá una u otra patología.

Un mismo conflicto de miedo por su seno, va a generar también tres patologías posibles:

- pleura,
- cerebelo,
- vacío emocional.

Ciertos bioshocks permanecen en el cerebro y por lo tanto no se expresan en el cuerpo: no se produce una «biologización» de los conflictos ya que dependen de la forma de vivir el conflicto, a veces con pequeñas sacudidas, con pequeñas soluciones y recidivas: el cuerpo se cura más rápidamente de estas pequeñas sacudidas, aunque todo se registra en la tríada psiquismo-cerebro-cuerpo, el bioshock genera más signos cerebrales o de trastornos psiquiátricos.

LOS DOLORES DE CABEZA, MIGRAÑAS Y CEFALEAS

LOS CONFLICTOS CEREBRALES EN GENERAL

- a. **Ciertos individuos** son más «cerebrales», intelectuales, mentales que otros; sin embargo, experimentan emociones por supuesto (si no fuera así, no enfermarían nunca).
- b. **El resentir de la patología cerebral** es: «*tengo que encontrar una solución con mis pensamientos*».

La persona no quiere perder el dominio (maestría), debe controlar, obtener la perfección. Está separada de un ideal, de un absoluto y siempre quiere sobresalir, hacer más. No se trata de ser débil, frágil y sin solución. Es la maestría imposible en cierto modo.

El estrés es intelectual, cerebral, muy elevado.

¿Cómo hace una persona cuando no tiene solución a un problema? «¡Esto no le ocurre nunca!».

Cada vez que la persona está en una situación sin solución, se halla exactamente en el estrés del momento del bioshock: por lo tanto y para evitarlo debe encontrar una solución en su cabeza → migrañas.

c. **La negación:**

No hay problema, el problema no existe. La negación afecta a personas que no están completamente encarnadas en sus cuerpos. Son cerebrales, intelectuales, un poco «en el aire».

- Tipos de personalidades que tienen tendencia a **evadirse en el sueño**: *personas que borran*, que no quieren afrontar la realidad, como si no pasara nada, como si el problema no existiera. Estas personas tienen *unas defensas muy importantes*: viven dramas como todo el mundo pero su **mecanismo de defensa es la negación**: «esto no es tan grave, no vale la pena preocuparse por ello...» Son personas que aparcan los problemas. *Pasan rápidamente en reparación* pero es una *reparación en balanza*, se encuentran regularmente confrontadas al problema: es en estos momentos cuando aparecen migrañas o cefaleas, localizadas en la zona del cerebro correspondiente en función de la tonalidad conflictiva.

d. **La duración:** los conflictos duran mucho tiempo.

e. **Acumulación de estrés y soluciones:** edemas acumulados y repetidos durante mucho tiempo.

- El problema, en ciertos casos, es que la persona *repite el mismo conflicto* (como un yoyo, durante años).
- Gran estrés + pequeña solución, repetitiva: la persona no puede llegar hasta el final, la curación siempre es interrumpida por un nuevo estrés, según un ciclo :
- Estrés → curación + pequeña solución → estrés → curación + pequeña solución, etc. Al cabo de un tiempo, los múltiples edemas se vuelven gelatinosos, ya no son de agua, son más espesos y no pueden desaparecer, permanecen en cantidades muy importantes.

- En **simpaticotonía**, observamos en el escáner un pequeño punto en el foco del órgano: el cerebro está en un programa de excepción, tiene que trabajar mucho durante horas → las células gliales intervienen proporcionando más oxígeno, alimento → programa de hiperactividad en funcionamiento.
- En **vagotonía**, es decir cuando la persona soluciona, se produce un edema de reparación, intra-focal y peri-focal (dentro y alrededor del foco cerebral correspondiente). Este edema es visible en la imágenes del escáner cerebral y aparece de color negro. Una vez finalizado el estrés, hace falta hacer balance, ordenar y limpiar, con las células gliales que se multiplican.

f. Aparece además, **el conflicto del riñón**, problema de referencias.

g. Las migrañas aparecen igualmente en los sujetos **entusiastas que no saben parar**.

Se trata de personas que nunca tienen suficiente, que tienen que superarse.

DOS TIPOS DE MIGRAÑAS

1. Migrañas de estrés :

En fase de simpaticotonía, hay que encontrar una solución, todo el mundo tiene que estar contento y hay que hacer siempre más. La persona rechaza la impotencia por encontrar una solución en su pensamiento.

Tiene **migrañas de estrés en compresión**, como si la cabeza estuviera comprimida y pocos medicamentos le alivian: las neuronas y células gliales están siendo muy solicitadas.

Buscar cual es el conflicto recidivante, que es repetitivo y que la persona no puede solucionar; cuando se encuentra la solución el estrés desaparece.

La persona ha de aceptar que a veces no hay solución y que puede seguir viviendo.

2. Migrañas de curación:

En la fase de reparación, relajación / vagotonía, el paciente no está en estrés pero tiene la sensación que la cabeza le va a estallar, a veces detrás de los ojos (**migrañas pulsantes**, que van hacia el exterior). Estas migrañas están causadas por el edema que con la hinchazón producen presión.

Una misma persona puede sufrir los dos tipos de migraña: en reparación, la migraña impide encontrar soluciones → migraña de estrés.

Durante esta fase de reparación:

No beber mucho, mantener la cabeza elevada, no exponerse al calor. Las migrañas pulsantes son más fáciles de aliviar con medicamentos que las migrañas de compresión. Aplicar hielo puede permitir reabsorber el edema.

Buscar el problema que la persona está tratando de resolver, lo positivo antes de que apareciera la migraña.

LOS TUMORES CEREBRALES

¿POR QUÉ SE UBICA UN CONFLICTO EN EL CEREBRO?

1. ALGUNAS PERSONAS SON MÁS « CEREBRALES », INTELECTUALES, MENTALES.

Sin embargo, tienen emociones, por supuesto (sin ellas la enfermedad no existiría)

2. RESENTIR: « DEBO ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN ».

La persona no quiere perder el dominio (maestría), ha de controlar, conseguir la perfección. Se halla separada de un ideal, de un absoluto y quiere superarse constantemente, hacer más. No es cuestión de ser débil, frágil y sin soluciones. Es en cierto modo la maestría imposible. El estrés intelectual es muy alto.

3. LA NEGACIÓN

No hay problema, el problema no existe. La negación afecta a personas que no están completamente encarnadas, integradas; personas cerebrales, intelectuales, un poco "en el aire".

4. LA DURACIÓN

Conflictos que duran mucho tiempo antes de que aparezca el tumor en el cerebro.

5. ACUMULACIÓN DE ESTRÉS Y SOLUCIONES

Edemas acumulados y repetidos durante mucho tiempo.

En fase de estrés: se observa un pequeño punto (en las imágenes del escáner cerebral) en el foco del órgano correspondiente al conflicto.

En fase de reparación: es decir cuando la persona soluciona y está en vagotonía, se produce un edema de reparación, intra-focal y peri-focal (dentro y alrededor del foco cerebral correspondiente). Este edema es visible en las imágenes del escáner cerebral y aparece de color negro. A continuación y en el transcurso de la segunda parte de la fase de reparación, las células gliales evacúan este edema.

Si esta alternancia de fases de estrés y reparación se repite varias veces; quedará un edema de forma permanente que se engrosará y solidificará y consecuentemente quedará una masa de células gliales. Todo esto aparece de color blanco en las imágenes del escáner cerebral.

El problema, en algunos casos, es que la persona se coloca nuevamente en el mismo conflicto: es una especie de yoyo durante años.

Gran estrés + pequeña solución, repetitiva: la persona no puede llegar hasta el final, la curación siempre se interrumpe por un nuevo estrés cíclico: estrés → curación con pequeña solución → estrés → curación con pequeña solución, etc. Al cabo de un tiempo, los múltiples edemas se vuelven gelatinosos, ya no son de agua, son más espesos y no pueden desaparecer, permanecen en cantidades muy importantes.

Al cabo de algunos años → tumor cerebral.

LAS ENFERMEDADES CANCEROSAS

ALGUNAS DEFINICIONES¹

Histología

...*oma* al final de una descripción médica = indicador de tumor.

Ej. **Sarcoma**² **Carcinoma**³ : *Sarc-* y *carc-* = indicadores de tumor canceroso.

Ejemplos :

Adenoma = tumor (glándulas) benigno.

Adenocarcinoma o **adenosarcoma** = tumor canceroso.

Osteoma = tumor (huesos).

Osteosarcoma = tumor canceroso.

Adenoma = hipertrofia benigna de una glándula (« -oma » = tumor; « aden- » = glándula; adenopatía = aumento del volumen de un ganglio).

Linfoma = proliferación de células linfoides.

Hepatoma = tumor de hígado.

Sarcoma (« -oma » = tumor; « sarc- » = cáncer) = tumor canceroso desarrollado a expensas del tejido conjuntivo.

Fibrosarcoma = cáncer de las fibras conjuntivas de la piel.

Angiosarcoma = cáncer en el tejido de soporte de los vasos sanguíneos de los órganos. Puede afectar al bazo, el hígado, la médula ósea, los miembros, etc.

Miosarcoma = cáncer en relación a los músculos.

Condrosarcoma = cáncer en relación con los cartílagos.

Osteosarcoma = tumor canceroso de los huesos.

Osteoma = tumor benigno de los huesos.

Mielosarcoma = cáncer de la médula ósea.

Sarcomatosis cutánea = cáncer de la piel como por ejemplo, el sarcoma de Kaposi.

Mioma = tumor benigno de los músculos.

Queloides = tumor benigno fibroso duro, se desarrolla en la dermis sana o cicatricial.

Para la medicina clásica existen 200 tipos de cáncer diferentes.

« Carci- »: cáncer.

Carcinoma = cáncer del tejido epitelial.

Adenosarcoma = cáncer en relación con las glándulas.

Sarcoma = cáncer en relación con el tejido conjuntivo.

1 Del Griego antiguo -ωμα, *ōma* (« tumor »), derivado de ὠμός *ōmos* (« duro, cruel, inhumano »).

2 Del Griego antiguo σαρκός, *sarkos*, genitivo de σάρξ, *sarx*, « carne, cuerpo ».

3 Del Griego antiguo καρκίνωμα, *karkinōma* (« cangrejo »).

HISTOLOGÍA

Cuando hay cáncer, nos apoyamos en la histología = estudio de los tejidos.

Cuatro tipos de tejidos:

Epitelio: como un muro de ladrillos. Epitelio glandular que produce (saliva, hormonas, ácidos...).

Epitelio de revestimiento que no produce nada (piel...).

Tejido conjuntivo: células dispersas con sustancia entre ellas.

Serosos: constituidos a su vez de tejido conjuntivo y tejido glandular (pleura, pericardio, meninges...).

Encontramos tejidos de las 4 etapas de la biología a los que podemos asociar cánceres:

1ª etapa: epitelio glandular = adenocarcinoma (glándulas) → ir a buscar una función arcaica.

2ª etapa: serosos = mesotelio (membranas) → ir a buscar una agresión a la integridad.

3ª etapa: tejido conjuntivo (huesos, ligamentos) = osteosarcoma → ir a buscar una gran desvalorización.

4ª etapa: epitelio de revestimiento = epiteloma de la piel → ir a buscar un conflicto relacional o social.

PARTICULARIDAD DEL CÁNCER

Es la multiplicación de células funcionales con ausencia de tejido conjuntivo (tejido que rellena).

La ausencia de tejido permite ir a lo básico, que es la multiplicación de las células.

Ejemplo: organizas una fiesta para el aniversario de tu hijo. Envías tarjetas de invitación, decoras la sala, decoras las mesas, pero todo esto no les interesa a tus invitados, ellos vienen a comer... el resto para ellos, es superfluo e inútil.

Estas células pues, se van a multiplicar y serán súper eficientes. Son células que no van a morir porque no tienen programada la muerte celular.

Quieren ser eternas, como un deseo de eternidad.

El profesor Israel dice: « Como una especie de fuerza de vida »

El cáncer no tiene conciencia de sus límites, los rechaza: « no quiero morir ».

LAS CAUSAS

Cada célula normal contiene un gen llamado proto-oncogén que, en determinadas condiciones, induce al cáncer. El estrés juega un rol importante en el cáncer y sobre todo en las metástasis, incluso veinte años más tarde; esto es debido a las células totipotentes, que sin embargo, sólo están presentes en el cuerpo desde la concepción hasta el segundo mes de embarazo.

Artículo del Profesor Israel

Cáncer: un programa de supervivencia.

“Viendo el carácter implacable de esta enfermedad (el cáncer), pienso que el azar no tiene nada que ver con ella y que en realidad, se trata más bien, de un verdadero programa de supervivencia. Las células cancerosas se proveen de un programa de supervivencia.

En primer lugar, hay que remarcar una cosa: las bacterias nacieron en este planeta hace aproximadamente, tres mil quinientos millones de años. Han resistido a todo. Estas bacterias demuestran la capacidad de adaptación que les han permitido superar todos los riesgos. ¿Cómo funciona este sistema de S.O.S.? Pues bien, responde a todo tipo de agresiones diferentes (disminución o desaparición del medio nutritivo, modificación del pH, la temperatura, etc.) desencadenando, al mismo tiempo, todo tipo de genes (una quincena en bloque). Todos estos genes están bajo el mando de un solo gen llamado Lex A. Del mismo modo, existe un único gen que desencadena el programa de supervivencia: Rex A que se activa ante cualquier tipo de agresión donde esté en juego la supervivencia de la bacteria.

En 1994, me quedé perplejo, cuando descubrí que existe una homología, entre los genes del sistema S.O.S y los genes activados en el cáncer.

De hecho, tan solo podíamos heredar genes de las bacterias. Solo se ha inventado un vida sobre este planeta. En consecuencia, somos hijos de las bacterias y hemos heredado su sistema S.O.S. Es el testimonio de la fuerza extraordinaria de la vida.

Estoy convencido de que el fenómeno al que denominamos cáncer, no es otra cosa que la reactivación en nuestras células de ese programa de supervivencia”.

LAS CÉLULAS CANCEROSAS

Los tumores cancerosos son un “turbo” de nuestra biología ya que los cánceres tienen algo específico: una muerte celular programada, la apoptosis, que es diferente de las células habituales, sanas. Una célula habitual se suicida al cabo de seis o siete duplicaciones; en cambio la célula cancerosa perdura en el tiempo. Todos los tejidos tienen células activas y, además, tejido conjuntivo. En el caso del cáncer, no hay tejido conjuntivo. Las células cancerosas son esencialmente células activas y, según el lugar donde proliferen, hacen lo que les es propio: en el estómago, producen ácido,... Es como si sólo hubiesen estas obreras super especializadas que gestionasen la construcción de pequeñas arterias y venas con el fin de aportarles lo bueno y retirar lo malo. Se trata pues, de un programa de urgencia muy adaptado para hacer frente a una situación grave de emergencia.

CÁNCER Y GENES

Según estudios realizados sobre ratas a las que se inoculó un ovocito portador de cáncer, se observó que las crías que nacieron no lo desarrollaron.

Esto tiende a demostrar que no desarrollamos un cáncer si no somos portadores de un conflicto determinado.

En el seno de una misma familia, no todos los miembros van a desarrollar un cáncer de generación en generación.

Que sea genético o no, ¿qué es lo que hace que no se manifieste al nacimiento sino más tarde?

→ Buscar el conflicto desencadenante, ir a buscar que es lo que pasó justo antes de la declaración del cáncer.

LECHE PROVINIENTE DE UN SENO CON CÁNCER

La leche proveniente de un seno canceroso tiene un poder nutritivo superior a la leche habitual de una mujer lactante. Del mismo modo, el ácido clorhídrico, los jugos gástricos que provienen de un cáncer de estómago tienen un poder de disolución superior a un ácido clorhídrico y a una enzima de un estómago normal.

¿En qué caso y en qué tipo de bioshock el cuerpo decidirá desarrollar un tumor maligno antes que uno benigno? Dependerá de si el acontecimiento pone o no la vida del individuo, su ser, su existencia en peligro. Cuando tenemos una espina en el estómago, no es mortal; nuestra integridad, nuestro ser no están amenazados y el tumor de adaptación será benigno. Por el contrario, si se trata de un hueso que puede amenazar nuestra identidad, ponerla en situación de riesgo, en peligro, es cuando se desarrolla el cáncer, el "turbo": el ácido clorhídrico es secretado en mayor cantidad para digerir más rápidamente, más eficazmente lo que hace peligrar la supervivencia. Esto significa que cuando el conflicto de origen simbólico, irracional llega y la persona lo vive en términos de agresión, de peligro de sí mismo, entonces aparece el cáncer con la siguiente consecuencia en psicoterapia: frente a un enfermo de cáncer, es indispensable hacerle trabajar sobre la definición de sí mismo, de su identidad.

El yo está ligado al sistema inmunitario cuya función es saber distinguir el yo del no-yo.

El sistema linfático, los glóbulos blancos ejercen de policía y piden a cada célula cuál es su identidad, su carné de identidad. Si es reconocida la dejan pasar, pero si no es el caso, el sistema inmunitario destruirá la célula. En el cáncer es conocido que la segunda fase de la enfermedad es la invasión de los ganglios, de los tejidos linfoides, hasta la destrucción de los tejidos linfoides inmunitarios y la afectación de los glóbulos blancos. Esto confirma que el cáncer está asociado al problema de identidad, de definición de su propio yo.

DESCUBRIMIENTO DE UN INVESTIGADOR BELGA

Esto ha sido confirmado por un investigador belga de la Universidad de Lovaina que descubrió que al normalizarse la célula cancerosa, se transforma en célula sana (lo que se observa desde hace veinte años en laboratorio), se desprende un glóbulo blanco. Podemos pues formular este descubrimiento:

Célula cancerosa = célula sana + un glóbulo blanco.

Las células cancerosas son como otra personalidad. Adquieren otra personalidad hasta aniquilar la primigenia y real personalidad del individuo.

Un cáncer = un conflicto + una creencia sobre la identidad.

¿Y EN RELACIÓN A LAS METÁSTASIS?

El cáncer se manifiesta en un lugar preciso, con una histología precisa.

Las células van a migrar a través de la sangre y los vasos linfáticos, generando otro cáncer con otra histología precisa.

Son cánceres diferentes, con historias conflictivas diferentes.

Ha habido varios bioshocks.

Hay metástasis cuando hallamos células de un tejido de un órgano, en otro. Por ejemplo, cuando constatamos una metástasis pulmonar de un cáncer de tiroides con células tiroideas en el interior de los pulmones, el conflicto es, por supuesto, una conjunción de dos resentires. La persona vive el conflicto siguiente: "Me doy prisa por vivir ya que mi muerte está próxima y llegará en segundo término" ya que se trata de un cáncer secundario.

RECIDIVA

Puede venir de un bioshock.

QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA

Es importante que las personas hablen de su tratamiento.

La mayoría de los tratamientos colocan a los pacientes en estrés, hasta en super estrés. Con frecuencia se produce una doble ambivalencia (aceptar la quimioterapia, ya que cura y rechazar la introducción de la química en el cuerpo) → como terapeutas, la labor es darles seguridad y animarles para seguir con su tratamiento.

- Hacerles trabajar el conflicto de evitación y de miedo. Prestar atención a la hora de fijar la próxima sesión en función de las fechas de la quimioterapia (evitar las consultas justo después de un tratamiento, la persona suele estar con frecuencia cansada).

CÁNCER Y DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA

El cáncer está con frecuencia asociado a la **identidad**.

- El preconflicto es: « ¿Quién soy? »: busco mi identidad, ya que me he identificado a algo exterior (espacio, trabajo, persona...)
- ¿Si ya no lo poseo más, para qué vivir? (si ya no tengo mi trabajo, mis hijos...)
- Tras la resolución, la biología genera un cáncer en previsión de futuro. "En el futuro el conflicto puede volver, he de estar fuerte" = **la biología hará más células**.

EN TERAPIA

Como complemento de la medicina, evidentemente!!

Rechazar el seguimiento de un paciente que rechaza su tratamiento médico.

- Ir en busca del duelo imposible (jubilación, duelo de un ser próximo, partida de los hijos, desenganche al tabaco, al alcohol...)
- **Hacer pasar al paciente de la identificación a la identidad:** El paciente puede decir: "¿Para que vivir si...?" »

Preguntas importantes que plantear:

- **¿A qué se identifica Usted?**
(¿Sobre qué está estructurado: trabajo, niños, asociación, alcohol,...?)
- **¿De qué tiene Usted miedo en el futuro?** ¿Desde cuándo? → línea del tiempo.

PROTOCOLO PARA TRABAJAR SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y APORTAR OTROS RECURSOS***Metáfora de los dos transatlánticos:***

En un puerto, hay dos transatlánticos.

Uno amarrado por una sola cuerda y el otro por veinte cabos.

Una noche, estalla una violenta tempestad.

Uno de los transatlánticos es arrastrado a la deriva muy lejos del puerto y el otro permanece en el muelle, bien amarrado...

Para ti, si hubiese una única cuerda que te atara al muelle, ¿cuál sería?

¿Cuál es tu dependencia, hoy en día?

Cuestionar al paciente sobre su dependencia:

- ¿Para qué vivir, si ya no puedes...?
- ¿Si ya no tienes...?
- ¿Si ya no eres...?

Preguntas para abrir nuevas vías:

¿Qué es lo que te motivaría seguir viviendo aunque ya no pudieras...?

- Si ya no tuvieras más...?
- Si ya no fueras más...?

El único cabo fuerte, es el que sólo depende de uno mismo y no de los otros. Es un vínculo fuerte.

LA GOMA Y EL TINTERO

Modelo de diagnóstico terapéutico, tabla de lectura de los síntomas, *basada en:*

1. DOS NOCIONES FUNDAMENTALES

+ **Más:** la amistad - oxígeno - calor...

- **Menos:** el frío, lo negativo...

A cada segundo hacemos los dos. Toda nueva información se clasifica en una de estas dos categorías. El universo tendrá un sentido según estas informaciones, a cada instante.

Más: lo que he evaluado como positivo y que el en caso de que haya conflicto y me sienta separado causará trastornos = quiero atrapar lo positivo.

Menos: estoy en contacto con lo negativo, agredido por lo negativo.

Goma = estructurado sobre un exceso de negativo.

Tintero = estructurado sobre una falta de positivo.

2. DOS TIPOS DE REACCIÓN

a. *Me siento separado de lo positivo* → **TINTERO:** añadir - coleccionar - hacer reservas - engordar - desarrollar una hiperactividad - etc.

La situación de partida es un vacío, una carencia, una ausencia → la solución es rellenar = tintero.

Me siento separado de lo que siento como positivo, vital, agradable. Puede tratarse de algo indispensable o simplemente placentero con todos los grados posibles entre los dos.

b. *Me siento agredido* → **GOMA:** borrar - olvidar - ocultar - anestesiar - suprimir - etc.

La situación de inicio es un exceso → la solución es la supresión, la reducción = goma.

El resentir puede ir desde un nivel inconfortable a un nivel vital, con todas las tonalidades intermedias.

3. REALIDAD A DISTINTOS NIVELES

- *Resentir a distintos niveles:* físico, emocional, sexual, intelectual, cultural, espiritual... Cada cual puede resentir, ya sea en goma o tintero a cada nivel.
- *Goma y tintero cohabitan:* podemos sentir agresión / goma a nivel físico y *simultáneamente* sentir una carencia / tintero a otro nivel, intelectual por ejemplo.

Podemos por ejemplo, tener un padre violento y consecuentemente borrarlos físicamente (cuanto más ausentes estemos físicamente, tendremos más posibilidades de sobrevivir). Y, en otro ámbito, intelectual, cultural u otro, puede que sea la carencia la que predomine; y, entonces, quizás vamos a crear, inventar, o ser muy curiosos ya que necesitamos rellenar.

EN TERAPIA: ORGANIZAR LAS DIFICULTADES EXPRESADAS

- **Tintero: sentirse solo, abandonado, aislado, separado de una relación o de otra cosa.**

¿Qué hay detrás de esto?. ¿Cuál es el problema previo?. *La persona se encuentra separada de sí misma.*

Si esta persona accede a una experiencia, a un recurso personal y está en contacto consigo misma, el abandono por parte del otro, la separación no constituyen un problema. Esto permite hacer el duelo en esta categoría de tintero y alcanzar a un encuentro **consigo mismo**; lo que proporcionará una sensación de densidad, de estatura, de centramiento, de estabilidad, de pesadez positiva, de enraizamiento y de presencia.

- **Goma: sentirse agredido, ensuciado, mancillado, amenazado....** Hay una sensación, ilusión o experiencia subjetiva de ser agredido por sí mismo. La persona dirá por ejemplo: « Soy malo, nulo o estúpido ». Los calificativos pueden ir del "no amable" al "culpable" pasando por el "inútil". La persona desconecta de sí misma y se evita; sintiéndose agredida por otra querrá evitarla. Evita reaccionar, afrontar, enfrentarse por miedo a causar pena, daño; se interioriza, se siente agredida pero es preferible a ser agresor. Busca el dominarse, el controlarse.

Se vive como agresora y agredida por sí misma.

En resumen:

Si me siento agredido = me vivo profundamente como agresor = me agredo yo mismo.

Si me siento separado = me siento deshecho, profundamente separado de mí mismo.

- **Goma + tintero en cada uno :**

Es algo muy característico: la persona salta de un nivel al otro, de la goma al tintero. Hay que intentar *separar estas partes de la persona*, colocando a cada una, por ejemplo y de forma simbólica, sobre una silla diferente, o bien una en la sala de espera y la otra en el despacho. De esta manera se puede trabajar neutralizándolas.

- **Contactar con la parte del tintero que se siente frustrada**, que tiene carencia y está ausente con tal de hacerla crecer y permitirle aceptar la frustración. Crecer no significa estar repleto, es aceptar las carencias y hacer los duelos. Esta frustración es necesaria para la evolución : el niño dejará atrás el vientre y el seno materno, irá al colegio y dejará a su madre, crecerá, se casará y dejará a sus padres para convertirse él mismo en padre, etc.

Hay que tratar de aceptar las carencias antes que rellenarlas.

- **Contactar con la parte de la goma, que está en la agresión :**
Frente a un exceso de negatividad, el objetivo de la terapia consistirá en aprender a existir frente al otro, a continuar siendo, a pensar, a resentir y *frente a lo desconocido, al peligro, a continuar existiendo, siendo, en lugar de borrarse.*

EJEMPLOS Y APLICACIONES EN DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA

La respuesta será o bien de tipo tintero (+) o bien de tipo goma (-) en cada nivel.

- **Trastornos de audición:** un mismo conflicto (no creo lo que escuchan mis oídos) puede provocar dos problemas opuestos = acúfenos o sordera.
- **Acúfenos:** no escucho lo que quiero escuchar → relleno este silencio insoportable.
Genero sonido.
- **Sordera:** me siento agredido a nivel auditivo → borro.
- **Peso y sobrepeso:** evaluar el sobrepeso en kilos: ¿Exactamente, cuántos kilos en más o en menos, juzga la persona que deberían ser normales para ella?. ¿Desde cuándo?. ¿A qué corresponde esta cifra de kilos de más?.

- **Sueño :**

Insuficiente = me siento agredido, he de prevenir el peligro; debo estar vigilante (miedo por uno u otra persona)

Exceso de sueño = me siento separado de los otros, de mi positivo y me duermo.

↑
.

- **Estudios y cursos :**

Demasiado estudios = He estado separado de la explicación, del sentido.

Falta de estudios = conocimiento y agresión van ligados. Nacimiento y agresión se unieron.

- **Sexualidad :**

Hiperactividad = separado del contacto físico (madre).

Hipoactividad = agredido por el contacto, en términos de piel.

Enfermedad de Alzheimer:

"Quiero por un lado, olvidarme de mis separaciones y, al mismo tiempo, no quiero ser invadido. Necesito al otro, que no esté demasiado lejos, pero tampoco demasiado cerca".

Goma y tintero a la vez: agresión y separación. " Se ocupan de mí (soluciono mi conflicto de separación) y tomo distancia porque estoy en mi mundo interior (soluciono mi conflicto de agresión) ".

Protocolo: Comer la bufanda

- 1) Describir una situación en la que se siente separado(a) de alguien
- 2) Buscar una relación totalmente positiva que tenga con otra persona
- 3) Poner una bufanda entre el(la) paciente y la persona positiva, que estará representada por algún objeto; silla, sillón, etc.
- 4) Describir esta relación positiva y sus calidades, NO a las personas
- 5) Terapeuta invita a el(la) paciente a comer esta relación positiva (bufanda), puede estimularle el cuerpo con la bufanda, (o invitarle a que lo haga), con el fin de que integre esta relación positiva y haga contacto con esta
- 6) Dejar a la persona el tiempo que necesite para que la integre (deberá entrar en contacto profundo con ella)
- 7) Amplificar todas las sensaciones agradables que experimente
- 8) Cuando se sienta totalmente bien, hacer la verificación final; si pensás en la persona de la que te sentías separado(a), ¿cómo te sentís ahora?

Copyright C. Flèche

Protocolo

Solucionar Conflictos Cerebrales

Para mí, decidir o controlar es: _____

Si no puedo controlar me siento: _____

Cuando no hay solución me siento: _____

Estar en lo concreto, en la materia, es: _____

El cambio imprevisto me hace sentir: _____

El conveniente de esto (tener que controlar, huir de la realidad, buscar soluciones siempre) es: _____

Lo que es más importante de todo esto (controlar, huir de la realidad, solucionar) es: _____

Copyright C. Flèche

Protocolo Triada de Percepciones

- 1) Poner en el suelo tres anclajes; psique, cerebro y cuerpo
- 2) Pararse:
 - En el de la psique y sentir la creatividad, el delirio y la fantasía propios
 - En el del cerebro y sentir la necesidad de controlar, de solucionar y la tensión
 - En el del cuerpo y sentir la encarnación, la eficacia y la actividad
- 3) Pensar en un problema que se tiene y pararse -con este- en cada anclaje, dándose tiempo de sentir la diferencia
- 4) Aportar:
 - Al primer anclaje (psique) conexión espiritual
 - Al segundo (cerebro) confianza y dejar ir
 - Al tercero (cuerpo) estar en el momento presente (el ahora)
- 5) Re-visitarse el problema desde estas tres posiciones

Copyright C. Flèche